جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ايمان عطا احمد عطا

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** التبين **العنوان :** 52 ش بلال حكر التبين البحري

رقم البطاقة : 28801200104704 **رقم التليفون :** 01003481193 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 20-01-1988 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ايمان عطا احمد عطا
National ID: 28801200104704

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS
صفحة كمبيوتر وبطن وجه ظهر صيغة
تدعيم



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	ايمان عطا احمد	**Case No.**	**328004**
Sex/Age	**Female 38 Y**	**Patient No.**	**24010**
Registered Date	**23/6/2026 09:08:53 AM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**13/7/2026 11:21:00 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**16/7/2026 01:19:18 PM**	**Pathology No.**	**1966/26**

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 23/06/2026, at 12:40 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Four grey-white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)?
- **Ductal carcinoma in situ:** Absent.
- **Microcalcification:** Present.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.

Results:
*** IPT (All controls showed appropriate reactivity):**
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 7/8).

Breast Biopsy
[[DOCTYPE:BREAST_BIOPSY]]

Patient Name	ايمان عطا احمد	**Case No.**	**328004**
Sex/Age	**Female 38 Y**	**Patient No.**	**24010**
Registered Date	**23/6/2026 09:08:53 AM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**13/7/2026 11:21:00 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**16/7/2026 01:19:18 PM**	**Pathology No.**	**1966/26**

- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 35%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Low (score +1).
- Ki67%: 35%.

***Scoring system: "ER, PR"*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

منطقة حلوان الطبية
مستشفى حلوان العام

Name : ايمان عطا احمد
Date :20-06-202:6

Bilateral breast non contrast mammography and sonography REVEALED:-

- **Acr : C**
- **Left breast show Multiple (at least 5) asymmetry & soft tissue solid masses with no vascularity on Doppler study showing peripheral edge shadowing & posterior acoustic enhancement one of them at 2 o'clock away from nipple measuring about 12x 15 mm , another one is seen at the axillary tail measuring about 11x19 mm and another one is seen at 3 o'clock pre-areolar , some ducts show dense calcifications BIRADS V.**
- left axilla showing multiple suspicious LNs globular in shape and peripherally attenuated .
- Right breast showing fibroadenosis with multiple adenotic nodules the largest one about 5.5 mm at 10 o'clock BIRADS III .

Conclusion :

- left sided Multiple asymmetry with suspicious masses and suspicious LNs for biopsy & contrast enhanced mammography breast study .

Dr/ Soha Ibrahim

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

جوستافروسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

10/04/2026

MDT FORM

ne:	ايمان عطا احمد عطا	MRN:	12561
:	39 Y	ID:	28801200104704
nopausal Sta	PRE	Phone:	01003481193
S SCORE:		Marital Status:	
:		Family History:	
Morbidity:	FREE	Reason Of MDT:	NEW CASE

Clinical Data:

IDC GII

8/8 **PR:** 7/8 **HER2:** 1 **KI67:** 35%

omammography:

s Workup:

ory:

se of left breast cancer multiple mass with axilly lns er 8/8, pr 7/8, her2 +1
7% 35% ct cap >> multiple HFLs, iliac bone secloretic lesions dynamic
live >> hemingioma mri lumbosacral >> degenrative changes bone
>> hot uptake in D7 + STERNUM

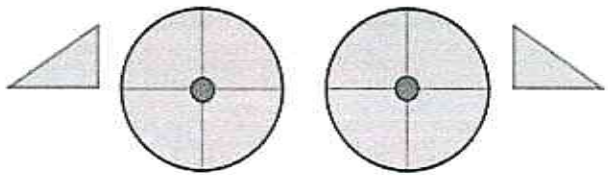
ER REVISION OF CT FILMS >> NO CHANGES IN STERNUM +
ENERATIVE CHANGES IN DORSAL AREA

MDT MEANWHILE FOR MRI DORSAL

ommendations:

OT METS OR OLIGO FOR NAct then It mrm

R L



TNM

Outcome & Plan

MRI dorsal spine then REMDT
nwhile to start AI/ZOLADEX until rolling out the nature of the spine lesion

SIGNATURE

DICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
anan Ezzat					

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]